



Collection MedWIZ

4^e année médecine

PNEUMO- PHTISIOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Pneumopathies bactériennes	8				
02	Pneumopathies virales (Covid-19)	12				
03	Bronchite aiguë	14				
04	Tuberculose pulmonaire commune	16				
05	Abcès pulmonaire	18				
06	Kyste hydatique du poumon	20				
07	Tuberculose extra-pulmonaire (TEP)	22				
08	Dilatations des bronches (Bronchectasies)	24				
09	Hémoptysie	26				
10	Tabagisme	28				
11	Pollution atmosphérique et pathologie respiratoire	30				
12	Asthme bronchique	32				
13	Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)	34				
14	Exacerbation de la BPCO (EABPCO)	38				
15	Insuffisance respiratoire chronique (IRC)	40				
16	Emphysème pulmonaire	42				
17	Dyspnée	44				
18	Épanchements pleuraux à liquide clair	46				
19	Syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS)	48				
20	Pleurésie purulente	50				
21	Pleurésie hémorragique	52				
22	Tumeur et adénopathies médiastinales	54				
23	Pneumopathies interstitielles diffuses subaiguës/chroniques	58				
24	Sarcoïdose	60				
25	Pneumoconioses	62				
26	Cancer broncho-pulmonaire primitif	66				
27	Tumeurs pulmonaires secondaires	68				
28	Embolie pulmonaire	70				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
29	Hémoptysie	74				
30	Syndrome médiastinal	76				
31	Syndrome bronchique	78				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

PNEUMOPATHIES BACTÉRIENNES (1)

I. DÉFINITION

- Infection aiguë (< 21 jours) des bronchioles terminales, alvéoles et/ou interstitium pulmonaire.
- Communautaires = extrahospitalières (vs nosocomiales > 48-72h d'hospitalisation).

II. ÉPIDÉMIOLOGIE

- 8,7% des décès mondiaux
- 24,5% des motifs de consultation en Algérie
- 1^{ère} cause de mortalité infectieuse dans les pays industrialisés
- 5-10% des infections respiratoires basses

III. ÉTIOLOGIES

- Altération des défenses non spécifiques (ciliaire, mucus)
- Déficits immunitaires (IgA, cancers, VIH, transplantés)
- Infection virale préalable (destruction épithéliale)
- Cause locorégionale (ORL, tumeur, corps étranger)

IV. DIAGNOSTIC POSITIF

Triade : Fièvre + Signes fonctionnels respiratoires (toux, expectorations) + Opacités radiologiques

V. PRINCIPAUX GERMES

Typiques	Atypiques (intracellulaires)
Pneumocoque +++	Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques	Chlamydia
Haemophilus influenzae	Legionella pneumophila
Klebsiella pneumoniae (alcoolique)	Rickettsies (Fièvre Q)
Staphylococcus aureus (enfant, diabétique)	Virus (grippe, VRS...)
Anaérobies (inhalation)	-

VI. FORMES ANATOMO-CLINIQUES

Critère	PFLÀ Typique (Pneumocoque)	Pneumonie Atypique (Mycoplasme)
Début	Brutal	Progressif (plusieurs jours)
Frissons	Présents	Absents
Température	39-40°C	38-39°C
Toux	Productive	Sèche, quinteuse
Expectorations	Purulente rouillée	Absente ou muqueuse
Signes physiques	Syndrome de condensation (matité, souffle tubaire, râles crépitants)	Râles bronchiques discrets
Signes extra-respiratoires	Variables	Présents (céphalées, myalgies)
Radiologie	Opacité alvéolaire homogène systématisée + bronchogramme aérique	Infiltrats interstitiels hilifuges, réticulo-micro-nodulaires

VII. REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- Les formes typiques sont souvent sévères et brutales.
- Les formes atypiques sont souvent plus modérées, traînent sur plusieurs jours.
- Le diagnostic repose sur la triade clinique et radiologique.
- L'étiologie oriente le traitement.

PNEUMOPATHIES BACTÉRIENNES (2)

VIII. DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

1. Embolie pulmonaire (fièvre + facteurs de risque)
2. Œdème pulmonaire cardiogénique (réponse aux diurétiques)
3. Atélectasie par obstruction (pas de bronchogramme aérique, rétractile)
4. Pneumopathies non infectieuses (tumeur, médicamenteuse, maladies systémiques)
5. Tuberculose (échec antibiotique)

IX. COMPLICATIONS

- Pleurésie
- Abcédation
- IRA
- Choc septique
- Décompensation d'affection sous-jacente

X. FACTEURS DE GRAVITÉ

- Âge > 65 ans
- BPCO, DDB, mucoviscidose
- Insuffisance rénale, cardiaque, hépatique
- Splénectomie, éthylisme, inhalation
- FR > 30/min, TA systolique < 90 mmHg
- Confusion mentale
- Extension radiologique > 50 % en 48h, épanchement, atteinte multilobaire, excavation
- GB < 4000 ou > 30000, Hb < 9g/dL, thrombopénie
- PaO₂ < 60 ou PaCO₂ > 50 mmHg

Score CRB-65 (1 critère = hospitalisation) :

- C Confusion
- R Respiratory rate > 30/min
- B Pression artérielle (PAS < 90 / PAD < 60)
- 65 Âge > 65 ans

XI. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

- ECBC : seuil > 10⁷ UFC/mL ou germe strictement pathogène
- LBA : seuil > 10³ UFC/mL (immunodéprimés)
- Antigénurie : pneumocoque, légionelle
- PCR : Mycoplasma, Chlamydia, Legionella
- Hémocultures (pneumocoque +++)

XII. TRAITEMENT (PROBABILISTE)

Situation	Antibiothérapie
Adulte sain ambulatoire	Amoxicilline 3g/j ou Macrolides
Suspicion atypique	Macrolides
Allergie pénicilline	Macrolides ou Pristinamycine
Hospitalisation non grave	Amoxicilline + Macrolide
PAC grave	Céphalosporine 3G + Macrolide (ou Fluoroquinolone)
Légionelle	Macrolides ou Fluoroquinolones
Klebsiella	Céphalosporine 3G
Staphylocoque (LPV)	Vancomycine + Clindamycine ou Linezolide

- Durée : 3 à 7 jours (5 jours en moyenne)
- Évaluation : 48-72h → apyrexie = bon critère ; échec = modifier l'ATB